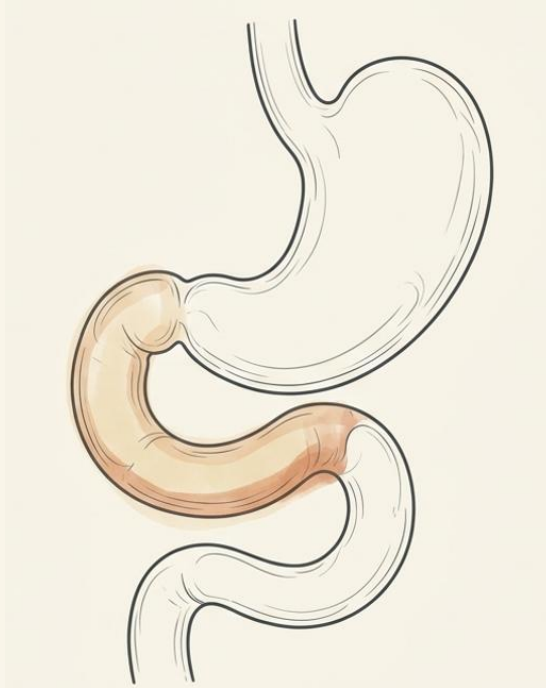


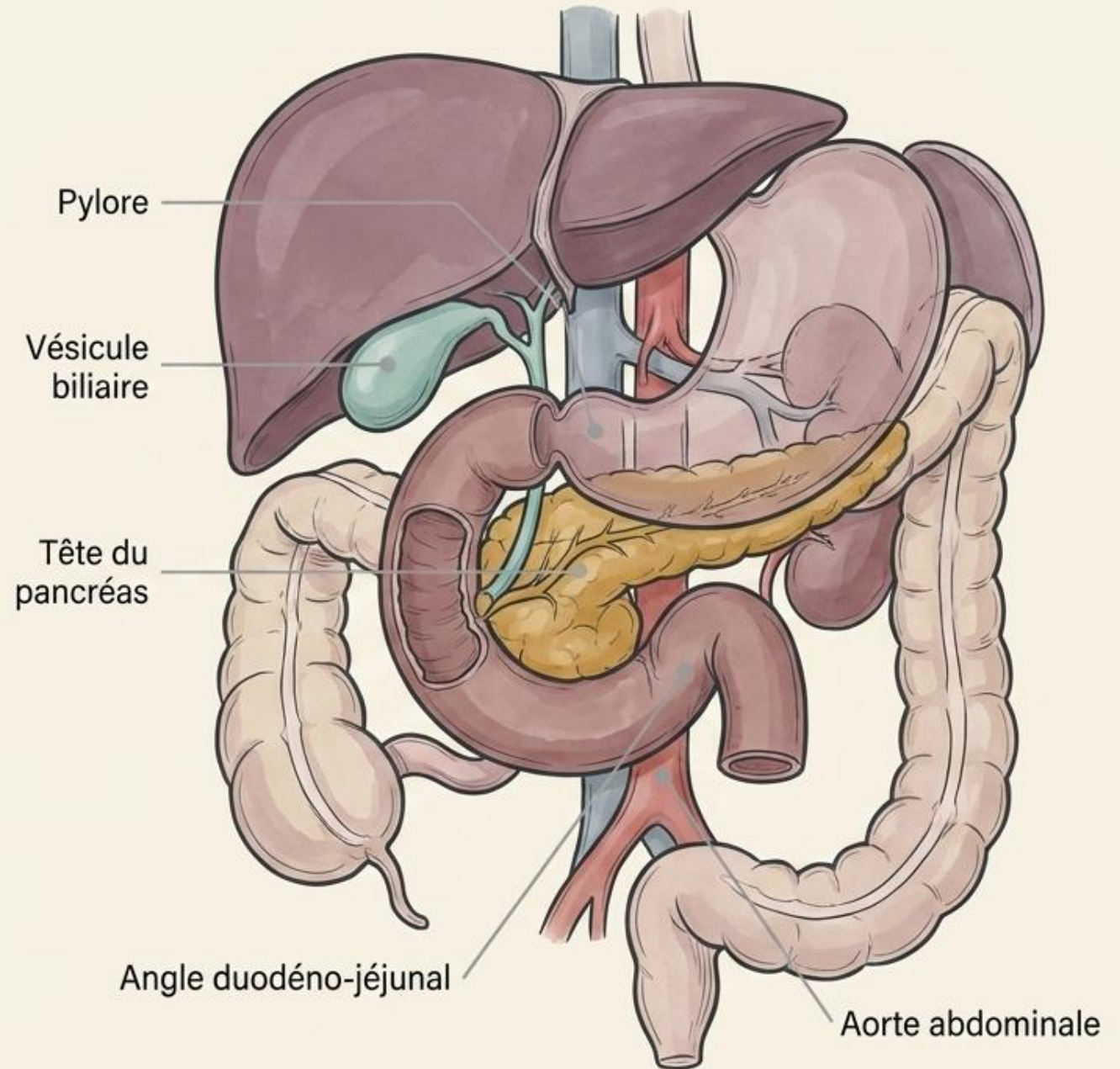


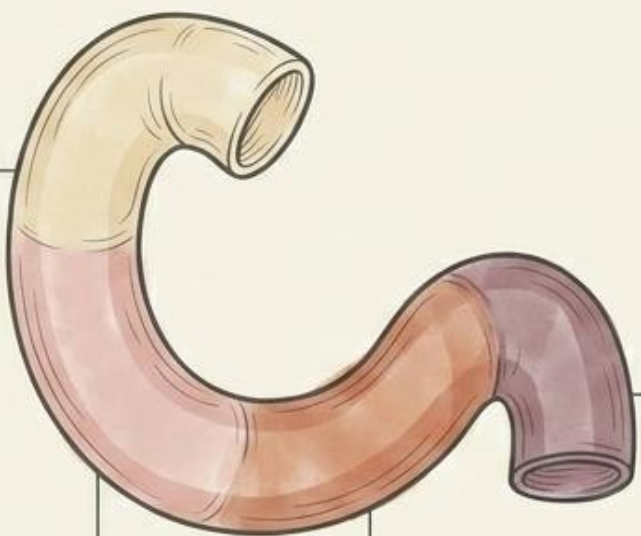
Chapitre 10 — Duodénum

Anatomie, Physiologie et Approche ROP

Le Carrefour Viscéral de l'Abdomen

- Morphologie : Organe en forme de U ou de C, d'environ 25 cm.
- Topographie : Partiellement rétro-péritonéal, appliqué contre la paroi abdominale postérieure.
- Rôle central : Relais entre l'estomac (pylore) et l'intestin grêle mobile, siège de la neutralisation acide et de la réception bilio-pancréatique.





D1 (Bulbo-pylorique)	D2 (Pancréatico-biliaire)	D3 (Vasculaire)	D4 (Jéjunal)
5-6 cm Oblique à droite, ascendant À droite de L1 Initiellement intra-péritonéal (bulbe). Rapport foie/vésicule. Angle : Genu superius.	8-10 cm Vertical descendant Flanc droit des lombaires Abouchement bilio-pancréatique. Solidaire de la tête du pancréas. Angle : Genu inferius.	6-9 cm Horizontal, concave En avant de L3 Croisé par les vaisseaux mésentériques.	6 cm Ascendant, oblique Flanc gauche (vers L2) Se termine à l'angle de Treitz.

Le hub sécrétoire : Focus sur D2 et les papilles

Papille duodénale mineure

Position : Située plus haut sur D2.

Structure : Abouchement du canal pancréatique accessoire de Santorini (lorsqu'il est présent et perméable).

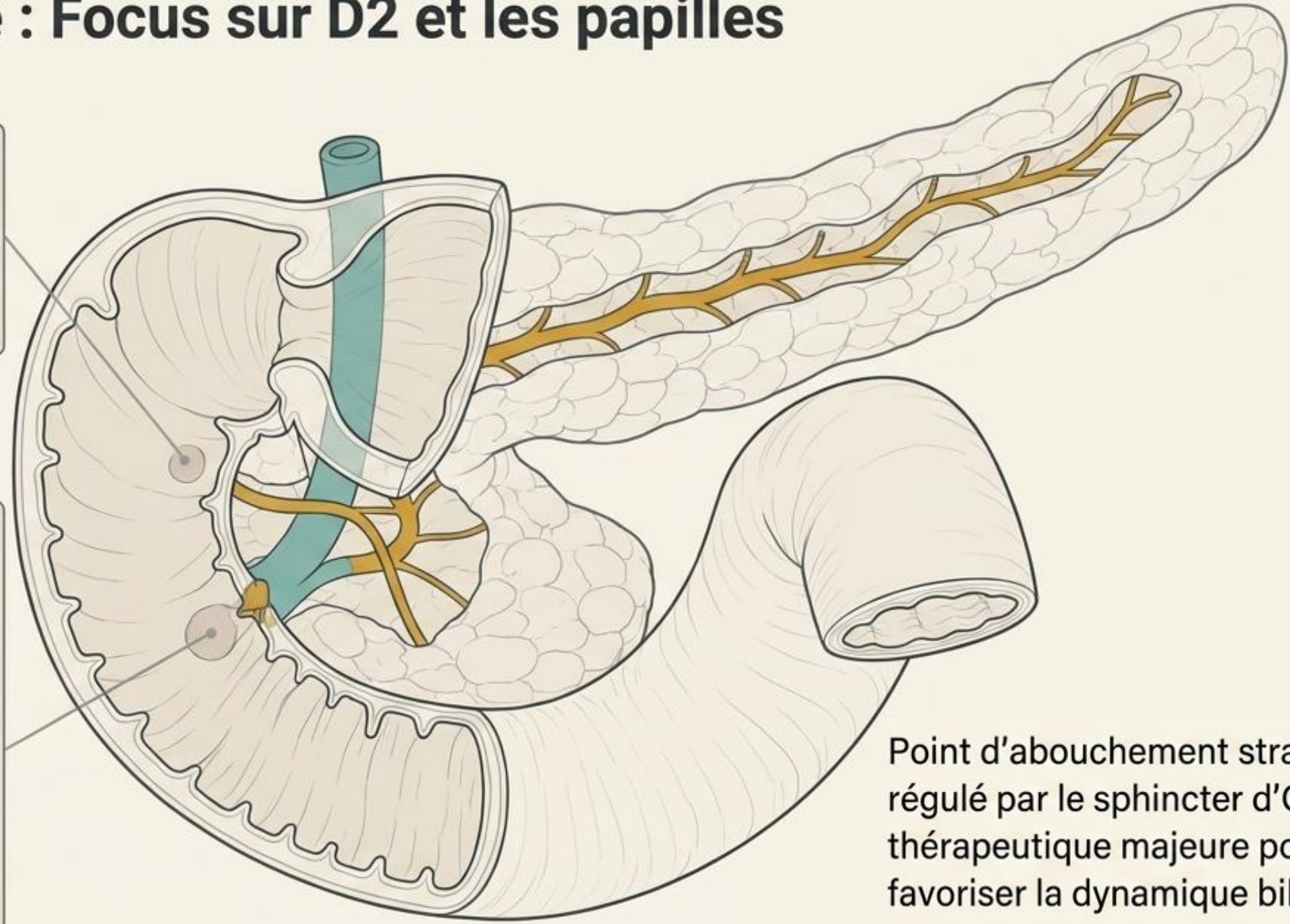
Papille duodénale majeure

Position : Union des tiers moyen et inférieur de D2.

Structure : Abouchement du canal cholédoque et du canal pancréatique principal dans l'ampoule hépatopancréatique. Régulée par le sphincter d'Oddi.

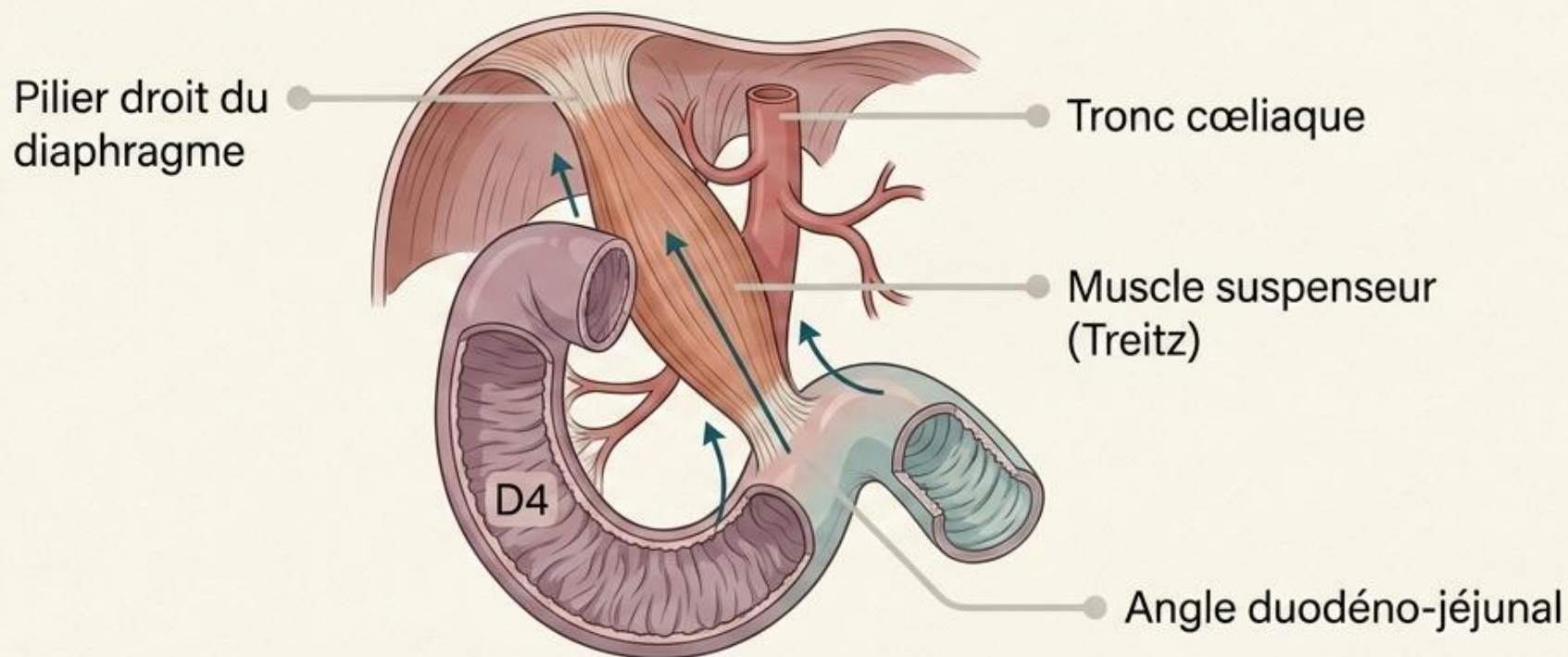
Repère Topographique Pariétal :

Ligne ombilico-médio-claviculaire droite, à environ 3 travers de doigt au-dessus de l'ombilic (vers L2).



Point d'abouchement stratégique régulé par le sphincter d'Oddi. Cible thérapeutique majeure pour favoriser la dynamique biliaire.

Le Muscle de Treitz et la Dynamique de Vidange



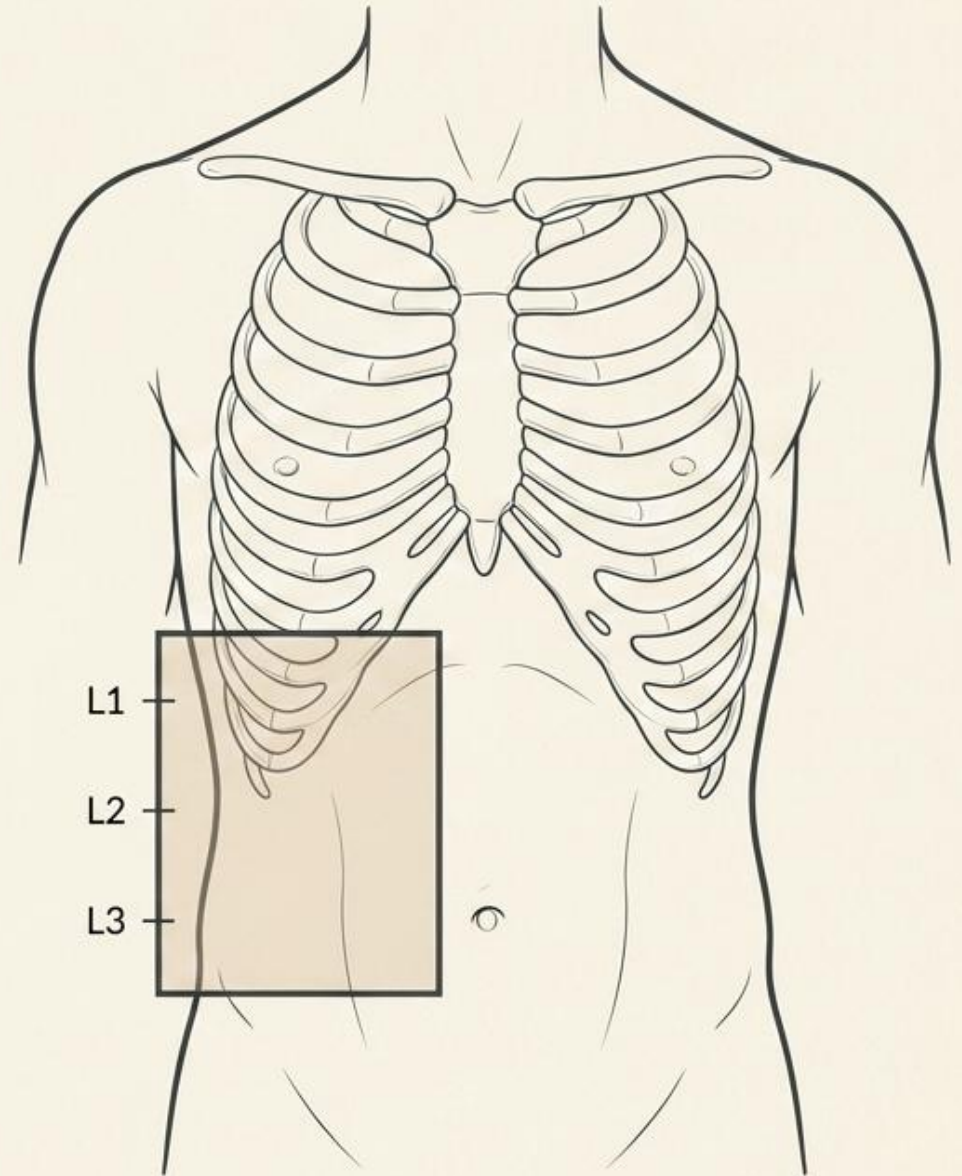
Action d'ouverture : La mise en tension du muscle participe activement à l'ouverture de l'angle duodéno-jéjunal, facilitant la vidange gastrique.

Tension mésentérique : Contribue au maintien de la tension longitudinale de la racine du mésentère (toute perte de tension réduit l'efficacité mécanique du duodénum).

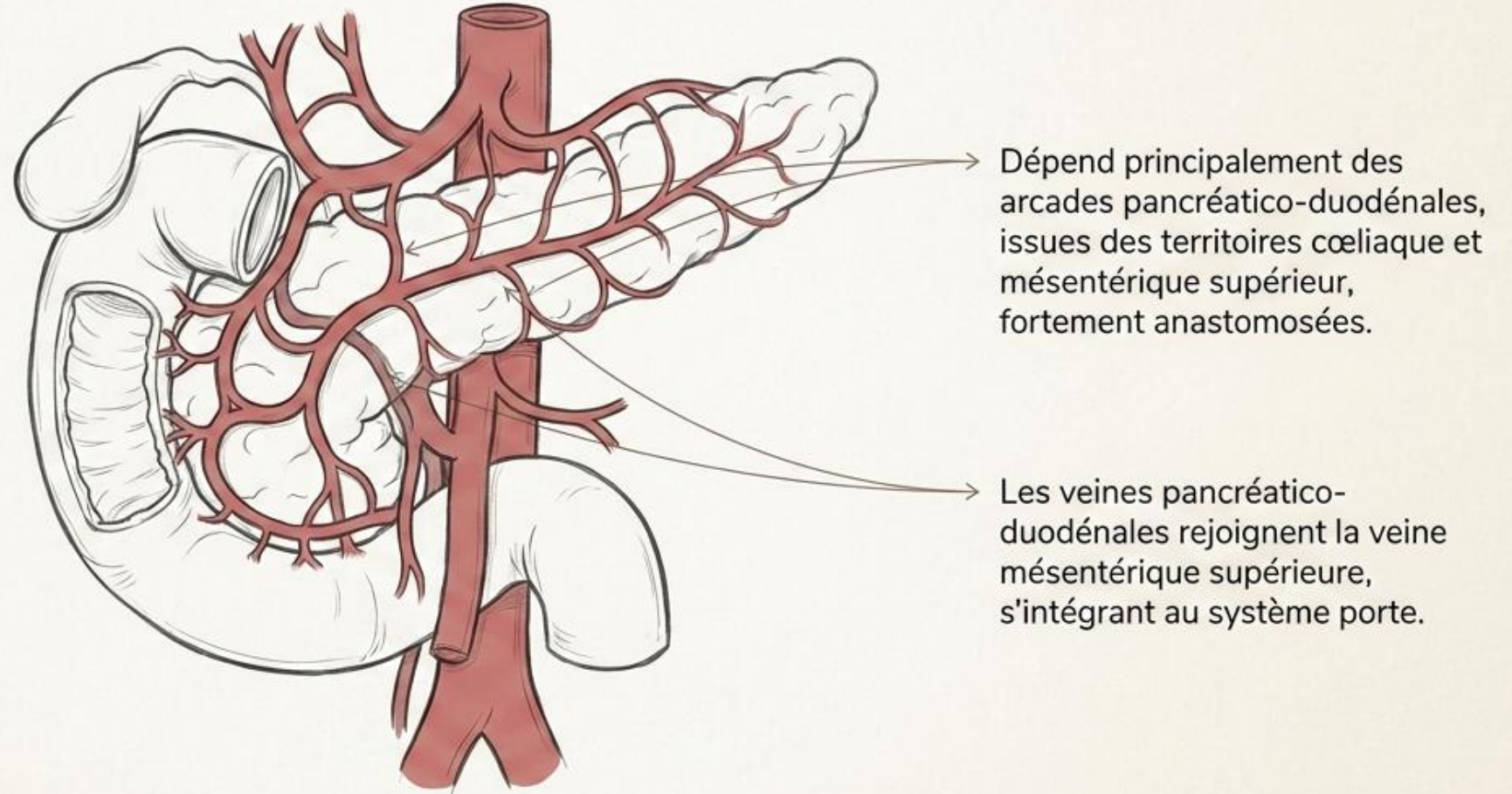
Cartographie palpatoire : Le Quadrilatère de Rogié

Repère clinique topographique

- **Définition** : Zone topographique clinique couvrant le flanc droit de L1 à L3.
- **Contenu** : Concentre les éléments viscéraux, vasculaires, nerveux et lymphatiques fortement solidaires du 2ème duodénum (D2).
- **Intérêt ROP** : Fenêtre d'accès majeure pour l'évaluation et la levée des tensions bilio-pancréatiques.



Vascularisation artérielle et veineuse



Réseau neurologique et autonomie

Parasympathique :
Innervation assurée par
les nerfs vagues (X).

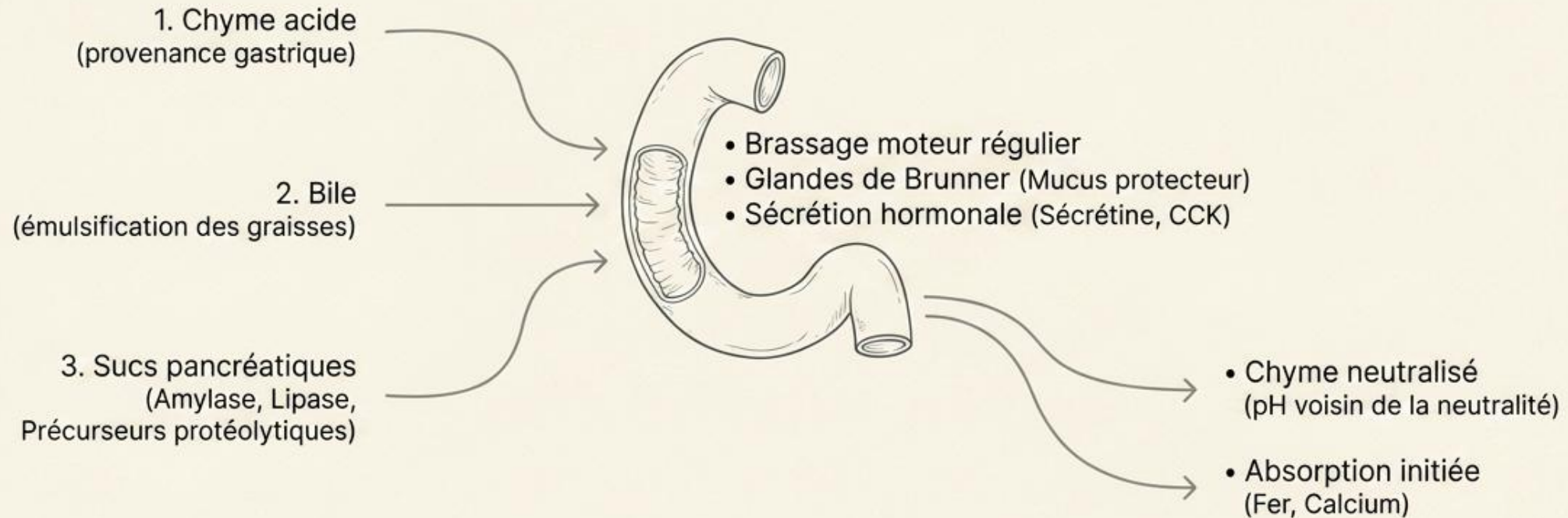


Sympathique : Implique
les fibres splanchniques
thoraciques et les plexus
prévertébraux.

Cibles : Plexus coélique et
mésentérique supérieur.

Dynamique sécrétoire et biochimique

Le sas de neutralisation et de digestion



L'usine sécrétoire : Régulation et hydrolyse



Fonction Hormonale

Sécrétine : Régulation antiacide, stimule la sécrétion pancréatique bicarbonatée.

Cholécystokinine (CCK) : Contraction de la vésicule biliaire, régule les sécrétions digestives en réponse au chyme.



Action Enzymatique

Amylase pancréatique : Hydrolyse de l'amidon et du glycogène.

Lipase pancréatique : Digestion des graisses (en synergie avec l'émulsification biliaire).

Précurseurs protéolytiques : Digestion des protéines (après activation luminale).

Protection et Absorption : Glandes de Brunner (mucus protecteur) et absorption initiale du fer, calcium, et micronutriments.

Grille de lecture pathologique

Atteintes organiques vs. Troubles fonctionnels

Atteintes Organiques (Diagnostics d'exclusion)

- Ulcère duodénal : Déséquilibre acido-peptique vs. défense muqueuse.
- Facteurs : Helicobacter pylori, AINS, tabac, stress.
- Signes : Brûlures épigastriques différées, nausées, complications (hémorragie, perforation, douleurs dorsales aiguës).

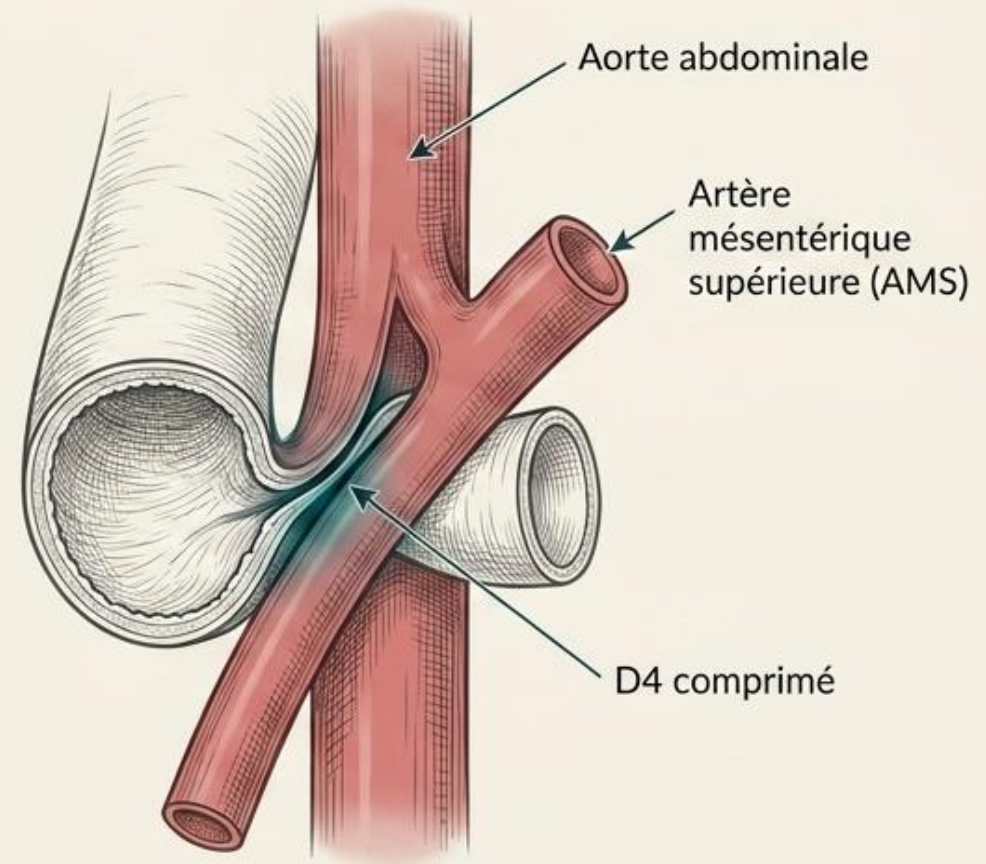
Troubles Fonctionnels (Cibles ROP)

- Duodénoparésie / Stase : Hypomotricité, parfois associée à une gastroparésie.
- Défaut mécanique : Perte de tension de la racine du mésentère, inefficacité du muscle de Treitz.
- Tensions bilio-pancréatiques : Spasmes perçus autour du sphincter d'Oddi.

Le conflit mécanique de D4

Syndrome de la pince aorto-mésentérique

- Mécanisme : Compression du 4ème duodénum (D4) entre l'aorte abdominale en arrière et l'artère mésentérique supérieure en avant.
- Conséquences directes : Ralentissement de l'évacuation du contenu duodénal vers le jéjunum (stase).
- Conséquences collatérales : Compression possible de la veine rénale gauche associée.



Objectifs thérapeutiques en ROP

Accompagner la motricité

Lever les spasmes
(duodénoparésie) et
favoriser l'évacuation
duodénale vers le jéjunum.

Favoriser la dynamique bilio-pancréatique

Travailler l'ouverture au
niveau des papilles.

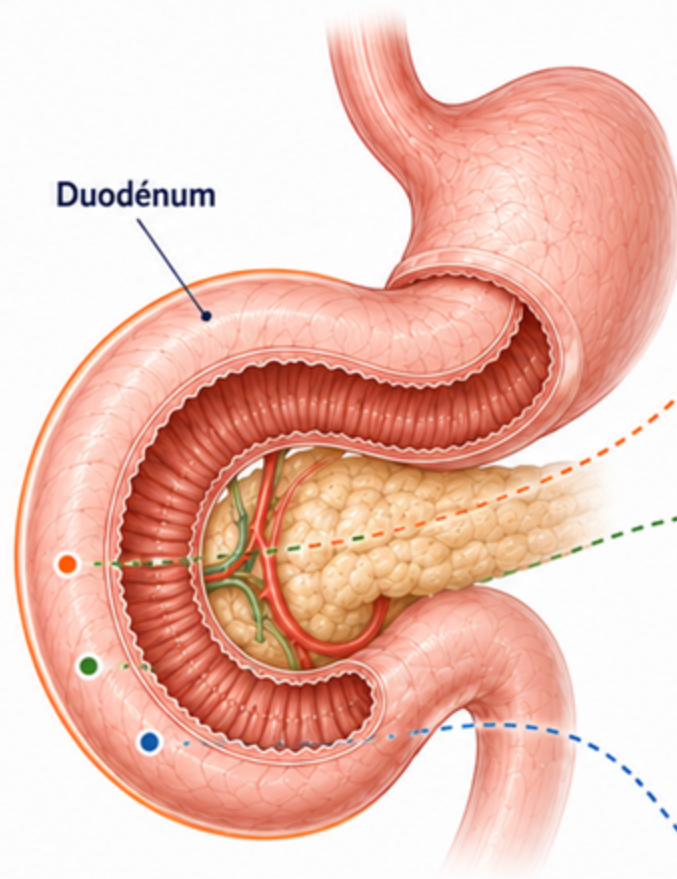
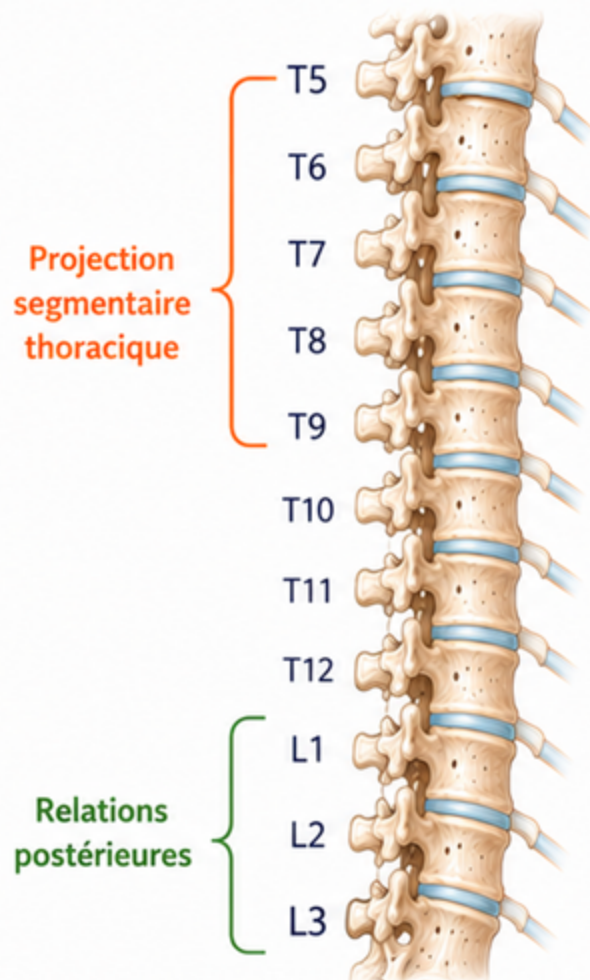
Réduire les tensions cliniques

Focalisation spécifique sur
le relâchement autour du
sphincter d'Oddi.

Le traitement duodénal s'associe aux viscères voisins : D1 avec l'estomac ; D2 avec pancréas/foie/vésicule ; D3/D4 avec grêle et racine du mésentère.

DUODÉNUM – RELATIONS VISCÉRO-SOMATIQUES

Repères somatiques conservés en lecture clinique ROP



T5–T9

Repères segmentaires

- Région paravertébrale thoracique moyenne à basse
- Jonctions costo-vertébrales correspondantes
- Prédominance clinique possible T7–T9



Relations postérieures – L1 à L3

Repères anatomiques complémentaires

- Charnière thoraco-lombaire
- Région lombaire haute
- Plan rétro-péritonéal et psoas droit



Diaphragme et ligament de Treitz

Relations anatomiques

- Pilier droit du diaphragme
- Flexure duodéno-jéjunale
- Zone sous-costale postérieure droite



Ces associations cliniques, non spécifiques, peuvent orienter la lecture et le protocole réflexe en ROP, sans se substituer à l'examen anatomique, au raisonnement clinique ni au diagnostic différentiel.